Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Местные признаки 2

2.3 Классификация Солдатова 3

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна 3

2.5 Жалобы и анамнез 4

3. Диагностика 4

3.1 Фарингоскопия 4

3.2 Анализы крови и мочи 5

3.3 Антистрептолизин-О 5

3.4 Исследование на БГСА 5

4. Лечение 5

4.1 При обострении (ангине) 5

4.2 Системные антибиотики 6

4.3 Межрецидивный период: консервативное лечение 6

4.4 Хирургическое лечение 6

4.5 Послеоперационное ведение 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании данных фарингоскопии: решающее значение имеют местные признаки хронического воспаления миндалин, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах. Размер миндалин диагностического значения не имеет.
- В период острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка его признаков возможна только **через 3–4 недели** после купирования острого процесса.
- По классификации Солдатова выделяют компенсированную и декомпенсированную формы; форму определяют по анамнезу **за последние три года**.
- Консервативное лечение назначают курсами в межрецидивный период:
  1. компенсированная форма: **2 раза в год**, весной и осенью;
  2. рецидивирующие ангины: **до 4 раз в год**, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Показания к тонзиллэктомии:
  1. любой вид декомпенсации;
  2. рецидивирующие ангины при неэффективности противорецидивного лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит является инфекционно-аллергическим заболеванием всего организма с местными проявлениями в виде стойкого воспаления нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Пять групп местных признаков

1. гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек;
2. рубцовые спайки между миндалинами и нёбными дужками;
3. разрыхлённые или, напротив, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины;
4. казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах;
5. увеличение регионарных лимфатических узлов.

1. признак Гизе: гиперемия краёв передних нёбных дужек;
2. признак Зака: отёк в месте соединения передних и задних дужек;
3. признак Преображенского: валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

Компенсированная форма

1. местные признаки;
2. общие симптомы нерезко выражены или отсутствуют.

Декомпенсированная форма: местные признаки и хотя бы один вид декомпенсации

1. рецидивы ангин;
2. паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс;
3. тонзиллогенная интоксикация: длительный субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности при отсутствии другой причины;
4. тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов;
5. заболевания органов, патогенетически связанные с тонзиллитом.

Форму определяют по данным анамнеза **за последние три года**.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

Простая форма

1. только местные признаки;
2. в подавляющем большинстве случаев в анамнезе ангины.

Токсико-аллергическая форма I степени (признаки периодические)

1. субфебрилитет;
2. слабость, быстрая утомляемость;
3. боли в суставах;
4. увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов;
5. непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца;
6. нестойкие отклонения лабораторных показателей.

Токсико-аллергическая форма II степени

1. функциональные нарушения сердечной деятельности, подтверждённые электрокардиографией (ЭКГ);
2. сердцебиение и нарушения ритма;
3. боли в области сердца и в суставах как во время ангины, так и вне её;
4. функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов.

Сопряжённые заболевания

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. парафарингит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. ревматизм;
5. артрит;
6. приобретённые пороки сердца;
7. гломерулонефрит.

Описано около 100 заболеваний, патогенетически связанных с хроническим тонзиллитом; наиболее часто поражаются сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В сложных случаях тактика ведения определяется совместно с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Местные жалобы

1. незначительная боль;
2. першение;
3. ощущение инородного тела в горле;
4. периодический сухой кашель;
5. неприятный запах изо рта.

Жалобы неспецифичны: встречаются также при хроническом фарингите, заболеваниях гортани, полости рта и зубов; у части пациентов жалоб нет.

Общие жалобы при декомпенсированной форме

1. длительное недомогание;
2. снижение работоспособности;
3. затяжной субфебрилитет.

Эти жалобы неспецифичны и требуют обследования для исключения других причин.

У детей и взрослых, особенно часто и длительно болеющих, уточняются местные и общие жалобы, а также частота ангин. Многие авторы считают ангины в анамнезе наиболее достоверным признаком хронического тонзиллита, однако сведения о них должны быть подтверждены.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза: ангины, длительная утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, сопряжённые с тонзиллитом заболевания;
2. физикального обследования;
3. лабораторных данных;
4. фарингоскопии.

3.1 Фарингоскопия

Показания

1. дети и взрослые: исключение острого тонзиллита и выявление местных признаков хронического тонзиллита.

При остром воспалении глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка признаков возможна только **через 3–4 недели**.

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Диагностические признаки

1. решающее значение имеют фарингоскопические признаки;
2. наиболее важный признак: жидкий гной в лакунах, нередко с неприятным запахом;
3. увеличение регионарных лимфатических узлов может быть обусловлено и другими воспалительными процессами головы и шеи;
4. размер миндалин диагностического значения не имеет.

Осмотр при ярком направленном освещении двумя шпателями, при необходимости зондом.

За 20–30 минут до осмотра пациенту не рекомендуется (иначе возможна транзиторная гиперемия)

1. принимать пищу;
2. пить горячие, холодные и газированные напитки;
3. курить;
4. разговаривать на холоде.

Надавливание вторым шпателем на нёбную дужку выявляет содержимое лакун и спайки.

3.2 Анализы крови и мочи

Показания

1. выявление сопряжённых с тонзиллитом заболеваний: общий анализ крови и мочи, С-реактивный белок (СРБ), ревматоидный фактор.

3.3 Антистрептолизин-О

Показания

1. дифференциальная диагностика активной стрептококковой инфекции и носительства.

Высокий уровень АСЛ-О при отсутствии стрептококка в посевах свидетельствует о возможной внутриклеточной персистенции и рассматривается как подтверждение декомпенсации. Однако высокий уровень АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не является показанием к лечению.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

3.4 Исследование на БГСА

Показания

1. бактериологическое исследование отделяемого с нёбных миндалин на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитологическое исследование содержимого лакун для постановки диагноза практически не имеют значения. Они необходимы для уточнения формы заболевания, роли микрофлоры, связи с заболеваниями других органов и оценки эффективности лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательства их эффективности отсутствуют.

---

4. Лечение

Перед началом любого лечения необходимы осмотр и при необходимости санация зубов, околоносовых пазух и носоглотки.

4.1 При обострении (ангине)

Тактика при ангине определяется рекомендациями по острому тонзиллофарингиту, при паратонзиллите и абсцессе рекомендациями по этим заболеваниям. Курсы лечения хронического тонзиллита назначают в межрецидивный период.

Взрослым при обострении рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения.

4.2 Системные антибиотики

При обострении, выделении стрептококка или признаках осложнений

1. системные антибиотики; препараты выбора: пенициллины.

Вне обострения: при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко повышенном АСЛ-О

1. 14-членные макролиды курсом **до 2 недель**.

Целесообразность антибактериальной терапии в межрецидивный период остаётся дискутабельной, поэтому решение принимается индивидуально на основании объективных данных, динамики симптомов и лабораторных показателей.

При подтверждённой грибковой этиологии используют противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

4.3 Межрецидивный период: консервативное лечение

Форма	Курсы консервативного лечения
Компенсированная, простая	2 раза в год, весной и осенью
Декомпенсация в виде рецидивов ангин, токсико-аллергическая форма I степени	до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины
Другие виды декомпенсации, токсико-аллергическая форма II степени	только при противопоказаниях к операции

1. Обязательное условие эффективности: дренирование лакун и очищение складок и карманов от экссудата и детрита.
2. Промывание лакун миндалин курсом **10 процедур** ежедневно или через день; не ранее чем **через 2–3 недели** после острого воспаления.
3. Антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.
4. Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания: уменьшают частоту и продолжительность обострений.
5. Растительные препараты курсами для снижения частоты ангин: корень алтея, цветки ромашки, трава тысячелистника, кора дуба, трава хвоща, корень одуванчика.
6. Консультация физиотерапевта в период ремиссии; физиотерапии предшествует курс промываний.

Для промывания используются стерильный раствор натрия хлорида или растворы антисептиков с соблюдением дозировок и возрастных ограничений и с учётом возможной аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур выполняют отдельно или непосредственно после промывания.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста от промывания и смазывания миндалин следует воздержаться в связи с риском рефлекторного ларингоспазма.

4.4 Хирургическое лечение

Двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в межрецидивный период для радикального устранения очага инфекции.

Показания к тонзиллэктомии

Основание	Показания к тонзиллэктомии
Классификация Солдатова	1. любой вид декомпенсации, кроме рецидивов ангин без проведённого противорецидивного лечения; 2. рецидивы ангин: при неэффективности консервативного лечения с сохранением ангин или появлением другого вида декомпенсации.
Классификация Преображенского — Пальчуна	1. токсико-аллергическая форма II степени; 2. простая форма и токсико-аллергическая форма I степени при неэффективности **2–3 тщательно проведённых курсов** консервативного лечения в год.
Дети	1. частые стрептококковые ангины: **не менее 7** за последний год, **не менее 5 в год** за последние 2 года или **не менее 3 в год** за последние 3 года; 2. два и более паратонзиллярных абсцесса (в ряде случаев и после одного); 3. заключение профильных специалистов, если тонзиллэктомия необходима как этап лечения сопутствующего заболевания.
Критерии Paradise	1. 7 эпизодов боли в горле за год, 5 эпизодов в каждом из двух лет или 3 эпизода в каждом из трёх лет. Эпизод: боль в горле и хотя бы один признак: температура тела 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов более 2 см с болезненностью, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютные противопоказания

1. заболевания крови: гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы;
2. аномалии сосудов глотки (пульсация боковой стенки);
3. тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени;
4. выраженная почечная недостаточность;
5. тяжёлый сахарный диабет с кетонурией;
6. тяжёлые заболевания печени;
7. тяжёлые нервно-психические заболевания;
8. злокачественные новообразования;
9. активный туберкулёз.

Относительные противопоказания

1. острые инфекционные заболевания и период 3–4 недель после них;
2. острые воспалительные заболевания и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов;
3. эпидемии гриппа;
4. менструация;
5. неактивный туберкулёз;
6. преходящая тромбоцитопения;
7. сахарный диабет нетяжёлого течения;
8. кариозные зубы.

Наиболее частое осложнение: кровотечение из тонзиллярной ниши во время операции или **в первые 5–7 дней**, возможно и **на 8–15-е сутки**. Поэтому первые 5–7 дней пациент находится в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике с освобождением от работы.

4.5 Послеоперационное ведение

1. в первые сутки постельный и голосовой режим; через несколько часов после операции разрешается несколько глотков воды;
2. в последующие дни щадящий режим, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная;
3. местные и системные анальгетики;
4. профилактика обострения сопутствующих заболеваний.

Для обезболивания и уменьшения воспаления используют НПВП.

После тонзиллэктомии в течение месяца рекомендуются ограничение физической нагрузки и соблюдение режима сна и отдыха.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Компенсированная форма: курсы лечения **2 раза в год**. Если **за 3 года** не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

Декомпенсация в виде рецидивов ангин: курсы лечения **3–4 раза в год**. При неэффективности лечения **в течение года**, осложнённом течении ангин или появлении другого вида декомпенсации пациента направляют на хирургическое лечение.

После тонзиллэктомии диспансерное наблюдение продолжается **6 месяцев**.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск развития хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно дефицит витаминов A, B, E), переутомление, неудовлетворительные гигиенические условия жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, заболевания зубов, полости носа и околоносовых пазух, частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и их нерациональное лечение.

Лечение, как правило, осуществляет оториноларинголог в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации в хирургическое отделение

1. неэффективность лечения;
2. подозрение на гнойное осложнение: паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит;
3. подозрение на новообразование;
4. необходимость хирургического лечения.

Тонзиллэктомию выполняют в оториноларингологическом отделении в плановом порядке; при неосложнённом послеоперационном периоде пациента выписывают **на 5–7-е сутки**.

Переход тонзиллита в декомпенсированную форму чаще наблюдается при иммунодефиците (врождённом, на фоне приёма иммунодепрессантов и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции). Аутоиммунные осложнения более вероятны при стрептококковой этиологии тонзиллита и ревматической лихорадке у пациента или ближайших родственников.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», тогда как в карточке рубрикатора приведён J31.2 «Хронический фарингит». На сайте указан код из текста КР.